

Briefing de Figuras — Capítulo 1

“O Homem que Morreu Saudável”

DIRETRIZES GERAIS (ambas as figuras)

Tom visual: clínico, limpo, sério — mas acessível. Não é paper acadêmico (sem excesso de grid ou legendas técnicas). Não é infográfico de Instagram (sem ícones coloridos, gradientes ou sombras). O modelo visual mais próximo: gráficos do *Outlive* (Peter Attia) ou do *Why We Sleep* (Matthew Walker) — figuras com fundo claro, tipografia sóbria, poucas cores com função semântica clara.

Paleta de cores sugerida:

- Verde escuro (#2D6A4F ou similar): zona ótima / segura
- Amarelo-âmbar (#E9C46A ou similar): zona de alerta / subótima
- Vermelho suave (#E76F51 ou similar): zona de risco
- Cinza médio (#8D99AE ou similar): faixa de referência “normal” do laboratório
- Azul escuro ou grafite (#264653 ou similar): dados do paciente / linha do gráfico
- Fundo: branco ou off-white (#FAFAFA)

Tipografia: sans-serif limpa (Inter, Source Sans Pro, Helvetica Neue ou similar). Títulos em 14–16pt bold, rótulos em 10–12pt regular. Nada em itálico nos gráficos. Sem serifa.

Formato de entrega: vetor (SVG ou AI) para versão impressa / PDF, + PNG em alta resolução (300 dpi, mínimo 2000px de largura) para versão digital. Fundo transparente ou branco.

Idioma: português brasileiro. Sem abreviações técnicas que não estejam no texto do capítulo.

FIGURA 1 — “O Filme que o Check-up Não Mostra”

Objetivo comunicacional

Mostrar visualmente que um número pode estar “normal” em cada medição individual, mas a **tendência ascendente ao longo dos anos** conta uma história de risco que nenhum resultado isolado revela. O leitor deve olhar para este gráfico e pensar: “Meu Deus, está subindo e ninguém falou nada.”

Posição no capítulo

Inserir **imediatamente após** o parágrafo que termina com: “...o diagnóstico de pré-diabetes vai chegar daqui a três ou quatro anos como uma ‘surpresa’ — que na verdade vinha sendo anunciada há quase uma década.”

Tipo de gráfico

Gráfico de linha simples com faixas de fundo coloridas (zonas).

Dados a representar

Momento	HbA1c (%)
2021	4,9
2024	5,2
2026	5,4
2028 (projeção pontilhada)	5,7

Estrutura visual

Eixo X (horizontal): anos — 2021, 2024, 2026, 2028. O ponto de 2028 deve estar em **linha pontilhada** (projeção, não dado real), com um pequeno rótulo: “projeção se nada mudar”.

Eixo Y (vertical): HbA1c em %, de 4,5% a 6,0%. Incrementos de 0,5%.

Zonas de fundo (faixas horizontais):

- **Verde claro** (4,5% a 5,2%): rótulo à direita → “Zona ótima para longevidade”
- **Amarelo claro** (5,2% a 5,6%): rótulo à direita → “Normal — mas subótimo”
- **Vermelho claro** (5,7% a 6,0%): rótulo à direita → “Pré-diabetes”

Linha de dados: cor azul escuro/grafite, espessura 2–3pt, com pontos marcados (círculos de 6–8pt). Os três primeiros pontos (2019–2023) são linha contínua. O quarto (2025) é

linha pontilhada com ponto vazado (não preenchido), indicando projeção.

Linha de referência “normal” do laboratório: uma linha horizontal tracejada cinza fina em 5,7% (limite superior de normalidade), com rótulo discreto: “Limite de normalidade (lab)”.

Anotações sobre os pontos de dados:

- No ponto de 2021 (4,9%): pequena etiqueta → “✓ Normal”
- No ponto de 2024 (5,2%): pequena etiqueta → “✓ Normal”
- No ponto de 2026 (5,4%): pequena etiqueta → “✓ Normal”
- No ponto de 2028 (5,7%): pequena etiqueta em vermelho → “Pré-diabetes”

Elemento-chave — a seta narrativa: entre os pontos de 2021 e 2026, uma seta curva sutil apontando para cima com o texto: “Cada resultado estava ‘normal’. A tendência não estava.”

Título da figura

“Três check-ups ‘normais’ — uma tendência perigosa”

Legenda/nota de rodapé

“HbA1c (hemoglobina glicada) reflete a média de açúcar no sangue nos últimos 2–3 meses. A faixa ‘normal’ do laboratório (abaixo de 5,7%) inclui valores que, embora não configurem pré-diabetes, já estão longe do ótimo para longevidade. A tendência importa mais que o número isolado.”

O que NÃO fazer

- Não usar gráfico de barras (a mensagem é sobre tendência/trajetória — precisa ser linha)
- Não incluir mais de um biomarcador neste gráfico (a simplicidade é o ponto)
- Não usar gradientes, sombras ou efeitos 3D
- Não colocar grade (grid) densa — no máximo linhas horizontais finas nas marcas de 0,5%

FIGURA 2 — “Os Números que o Check-up de Ricardo Não Investigou”

Objetivo comunicacional

Mostrar visualmente, para cada biomarcador, **três posições**: (1) onde Ricardo estava, (2) o limite “normal” do laboratório, e (3) a faixa ótima para longevidade. O leitor deve ver de relance que todos os valores de Ricardo estavam no espaço entre “normal” e “ótimo” — exatamente no ponto cego do check-up convencional.

Posição no capítulo

Inserir **imediatamente após** o parágrafo sobre a angiotomografia, antes do parágrafo: *“Nenhum desses números, isoladamente, teria disparado um alarme...”*

Tipo de gráfico

Dot plot horizontal (gráfico de pontos) — cada biomarcador é uma linha horizontal com três marcadores posicionados ao longo de uma escala.

Dados a representar

Biomarcador	Ricardo	Limite “Normal” (Lab)	Alvo Ótimo (Longevidade)	Unidade
Insulina de jejum	14	25	< 8	μIU/mL
ApoB	118	130	< 90	mg/dL
hs-CRP	2,4	3,0	< 1,0	mg/L
Homocisteína	13,8	15	< 10	μmol/L
Idade arterial*	68 anos	—	= idade real (52)	anos

*Para a idade arterial, não há “limite de lab” — o comparativo é a idade cronológica real.

Estrutura visual

Layout: 5 linhas horizontais empilhadas, uma por biomarcador. Cada linha é uma escala com:

Zonas de fundo em cada linha:

- **Verde** à esquerda: zona ótima (abaixo do alvo ótimo)
- **Amarelo** no meio: zona subótima (entre o ótimo e o limite de lab)
- **Branco ou cinza claro** à direita: zona que o lab considera “normal” mas que já está

longe do ideal

Marcadores em cada linha:

- **Triângulo verde (▲)** ou linha vertical verde: posição do alvo ótimo
- **Linha vertical tracejada cinza:** limite de normalidade do laboratório
- **Círculo azul escuro preenchido (●):** valor do Ricardo

Resultado visual esperado: em todas as 5 linhas, o círculo azul (Ricardo) fica entre o triângulo verde (ótimo) e a linha cinza (limite do lab) — sempre na zona amarela. Esse padrão repetido em todas as linhas cria o impacto: “Ele estava ‘normal’ em tudo. E ‘subótimo’ em tudo.”

Para a linha de “Idade arterial”: usar uma escala de anos (45 a 75). A posição “ótima” seria 52 (idade real). O ponto do Ricardo está em 68. A diferença visual de +16 anos é o ponto. Não há “limite de lab” nesta linha — apenas o contraste entre idade real e idade arterial.

Rótulos

- À esquerda de cada linha: nome do biomarcador em bold + unidade em regular
- Acima do gráfico (legenda de símbolos):
 - ● Valor do Ricardo
 - ▲ Alvo ótimo para longevidade
 - | Limite de normalidade (laboratório)

Título da figura

“Todos os números de Ricardo estavam ‘normais’. Nenhum estava ótimo.”

Legenda/nota de rodapé

“Em azul, os valores reais de Ricardo. Em verde, os alvos ótimos baseados em estudos de longevidade e centenários. A linha tracejada cinza mostra o limite de ‘normalidade’ usado pelo laboratório. Todos os valores de Ricardo estavam dentro da referência — mas todos estavam na zona subótima, onde o risco se acumula silenciosamente.”

O que NÃO fazer

- Não usar gráfico de barras verticais (dificulta a comparação lado a lado de três posições por marcador)

- Não incluir mais de 5 biomarcadores (poluição visual; estes 5 são os que aparecem no texto)
 - Não numerar os eixos com excesso de marcas — os três pontos de referência (ótimo, Ricardo, lab) já são suficientes
 - Não usar escala unificada para todos os marcadores (cada um tem sua própria unidade e faixa — escalas individuais por linha)
 - Não incluir o CAC score numérico (187) como biomarcador separado — a “idade arterial” (52 vs 68 anos) já traduz esse dado de forma mais impactante
-

CONSIDERAÇÃO SOBRE CAPÍTULOS FUTUROS

Estas duas figuras são as únicas recomendadas para o Capítulo 1. A partir do Capítulo 4 (biomarcadores) e do Capítulo 5 (CAC score), o volume de figuras deve aumentar naturalmente, incluindo:

- Tabela completa de biomarcadores com faixas ótimas vs. normais (Cap. 4)
- Imagens explicativas do Agatston score / CAC por faixa (Cap. 5)
- Diagrama da cascata metabólica: hiperinsulinemia → inflamação → aterosclerose (Cap. 6)
- Template visual de semana de treino (Cap. 7)
- Diagrama do eixo HPA (Cap. 9)
- Timeline de rotina circadiana ideal (Cap. 10)
- Scorecard de autoavaliação AGIR (Cap. 11)

Essas figuras serão briefadas quando os respectivos capítulos forem escritos.